

1 大腸癌の薬薬連携 — 経口薬・携帯型ポンプ・抗EGFR抗体

病院薬剤師	病院と共有する情報	保険薬局薬剤師
① 原発部位とRAS/BRAF/MSI/HER2から、レジメン選択の妥当性を監査	⇒ UGT1A1の結果 (イリノテカンの減量)	⇒ ① FTD/TPIは「5日服用・2日休薬」を2週、カペシタピンは「14日服用・7日休薬」を層で確認
② UGT1A1の結果から、イリノテカンの減量の要否を確認	⇒ 服用カレンダー (カペシタピン・FTD/TPI)	⇒ ② レゴラフェニブは低脂肪食後の服用と、開始2か月の肝機能・手足症候群を確認
③ オキサリプラチンの累積量としびれから、休薬の判断を支援	⇒ 皮疹のGrade・Mg値 (抗EGFR抗体)	⇒ ③ カペシタピンとワルファリンの併用はINR測定の前定を確認(添付文書の警告)
④ ペバシズマブ等の手術前後の休薬期間を管理	⇒ しびれの経過 (オキサリプラチン累積量)	⇒ ④ 携帯型ポンプの抜針後に、下痢・口内炎を電話で確認
⑤ 抗EGFR抗体投与時のMg測定・補充とインフュージョンリアクション対策		⇒ ⑤ 抗EGFR抗体の皮疹に、保湿剤・予防内服・外用ステロイドの使い方を指導

2 主なレジメンと薬局での確認ポイント

mFOLFOX6 点滴・注射	オキサリプラチン+レボホリナート+5-FU急速静注 → 5-FU 46時間持続静注	2週毎	✓ 携帯型ポンプの管理・抜針日 ✓ 寒冷刺激による急性しびれ
CAPOX 点滴+経口	オキサリプラチン(1日目)+カペシタピン 1日2回 1~14日目内服	3週毎	✓ 内服日数と休薬期間 ✓ 手足症候群 ✓ ワルファリン併用時のINR
FOLFIRI 点滴・注射	イリノテカン+レボホリナート+5-FU急速静注 → 46時間持続静注	2週毎	✓ 遅発性下痢時の下痢止めの使い方 ✓ UGT1A1 ✓ 脱毛
FTD/TPI 点滴+経口	トリフルリジン・チピラシル 1日2回 1~5日目・ 8~12日目内服(土ペバシズマブ)	4週毎	✓ 食後服用(空腹時は吸収が増え好中球減少が増強) ✓ 骨髄抑制
レゴラフェニブ 経口	1日1回 1~21日目内服(低用量から漸増する方法も)	4週毎	✓ 低脂肪食後に服用 ✓ 手足症候群 ✓ 投与初期2か月の肝機能・血圧

● 経口 ● 点滴・注射 ● 点滴+経口 経口薬は保険薬局で交付:服用日・休薬日と自宅での副作用を確認

3 相互作用・併用注意(他院処方・市販薬・サプリを含む)

重要度	薬剤(機序)	相手の薬(区分)	起こること	薬局での対応
禁忌 添付文書 併用禁忌	S-1 DPD阻害(ギメラシル)	処方薬 他のフッ化ピリミジン系(カペシタピン・5-FU等)	5-FU濃度↑ → 重篤な骨髄抑制・下痢	切り替え時は7日以上空ける
注意 添付文書 警告・併用注意	カペシタピン・S-1 CYP2C9の抑制	処方薬 ワルファリン・フェニトイン	INR↑(出血)・フェニトイン中毒	INR測定の頻度を処方医と確認
注意 添付文書 併用注意	レゴラフェニブ CYP3A4阻害・誘導	処方薬 クラリスロマイシン・アゾール系・リファンピシン	副作用↑・効果↓	他院の抗菌薬・抗真菌薬の処方を確認
注意 添付文書 用法	レゴラフェニブ 食事で吸収が変化	生活習慣 空腹時・高脂肪食後の服用	効果減弱のおそれ	低脂肪の食事の後に服用するよう指導
注意 添付文書 用法	FTD/TPI 空腹時は吸収が増加	生活習慣 空腹時の服用	好中球減少が増強	朝・夕の食後に服用するよう指導
確認 服薬指導上の注意	イリノテカン(遅発性下痢) 過量・症状を隠す	市販薬 市販の下痢止め	脱水・感染性腸炎の見逃し	下痢止めの使用量と回数、発熱の有無を確認

4 服薬指導タイムライン — 大腸癌のレジメンに合わせて

① CAPOX・FOLFOX開始時	② ポンプ抜針後	③ 経口薬の休薬期間	④ レゴラフェニブ開始~2か月
“冷たい物に触れると、指先やのどがピリッとなります。手袋や常温の飲み物で予防しましょう”	“ポンプを外した後から、口内炎や下痢が出やすくなります。水のような便が続く時は連絡を”	“お休みの間も体調は変わります。飲み忘れた分は、次の回にまとめて飲まないでください”	“足の裏の赤みや痛みは、飲み始めて1か月以内にしやすいので、厚手の靴下と保溫で予防しましょう”
✓ 薬局で確認 カペシタピンの服用日と休薬日、ワルファリン・フェニトインの併用	✓ 薬局で確認 抜針できたか、下痢の回数・水分量、口内炎の有無	✓ 薬局で確認 残薬からカペシタピン・FTD/TPIの服用日数を確認	✓ 薬局で確認 手足症候群のGrade、家庭血圧、処方箋の検査値で肝機能
△ ここに注意 ワルファリン併用中はINR測定の予定を確認	△ ここに注意 イリノテカン後の水様便と発熱は至急連絡	△ ここに注意 FTD/TPIは空腹時を避け、朝夕の食後に服用	△ ここに注意 だるさ・黄疸は肝障害を疑い至急連絡